EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67334
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-07-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALEJANDRO SEPULVEDA VERA			RUN	: 4.972.435-7
F.Nac	: 31-10-1943	Edad	: 79 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: POBL.ORIENTE NRO 18 LLAHUIMAVI			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-07	Fecha Egreso	: 13-07-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J93.9-NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONIA DERECHA
DERRAME PLEURAL DERECHO
SECUELA ACV ANTIGUO -> HEMIPLEJIA DERECHA /EPILEPSIA 2°/POSTRADO
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Masculino de 79 años, postrado, ingresa por clínica respiratoria tos productiva, CEG. con req de O2 bajos.
Exámenes de ingreso destaca leucocitosis, PCR elevada, OC no inflamatoria.
TAC de tórax con derrame plural masivo a derecha. Cardiomegalia y signos de HTP.
se hospitaliza para manejo con ABT de 1ra línea.
Evaluado por cx descarta instalación de SEP.
Se realiza toracocentesis (07/07) se extraen 400ml ; Rx control no se aprecian cambiso significativos con respecto a anterior
Se rescata Citoquimico de LP--> Criterios de Light: Exudado
Persiste compromiso general y rechazo de alimentacion por lo que fono sugiere mantener SNG
Lab control buena funcion renal sin DHE con parametros inflamatorios en descenso .
Cultivo Liq Pleural: NEGATIVO en 72 hrs incubación
Hoy algo mejor conectado al medio, pero mantiene rechazo alimentario
Completa tto atb Ceftriaxona 7 dias, afebril, sin requerimiento de O2 adicional, pero alternante en su conexión al medio.
Por lo anterior de decide hospitalización domiciliaria, para proseguir manejo kinésico, y de fono, para evaluar retorno a alimentación vo. Se hace educación a familiar responsable en uso y manejo de SNG.
El dia 12/07 se reevalua paciente evaluando uso/riesgo de terapia anticogulante en el contexto de paciente postrado, movilidad extremamente reducida y en discusion clinica se decide no Anticoagular y mantener terapia antiagregante.

PLAN DE MANEJO:

Seguimiento por fono -> alimentacion mixta?
Optimizar kine y estimulacion por fono
Pendiente evaluacion nutricional
seguimiento por programa de postrado de consultorio de origen

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo, semisentado, movilizar en cama
2. Prevención de UPP / Contención SOS
3. Regimen por SNG: Fresubin a 40 ml/hra
4. Seguimiento por fono (evaluar retorno alimentacion vo)
5. CSV cada 12 hrs + HGT sos - No reforzar
6. Kine resp / motora por 2 + Terapia y seguimiento por FA
7. TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES:
8. FENITOINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
9. ATORVASTATINA 20MILIGRAMOS 1 COMP AL DIA VO
10. PARACETAMOL 1 G cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL, SOS SI FIEBRE
11. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
12. IPRATROPIO INHALADOR 4 puff inh cada 6 hrs
13. ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG 1 comprimido diario 20 dias
14. CLOPIDOGREL 75 MG VO 1 comprimido diaropor 20 dias

Control en: 20 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO